

Datos Personales							
Nombre:	LINA MARIA MERIÑO SAUCEDO	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2011-06-20	Edad	14 Años, 7 Meses, Y 3 Días
Identificación:	TI - 1064556442	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Dunissaucedo23@hotmail.Com - 1064556442			Dirección:	Conjunto Villa Ligia 4 Mz C Casa 15.		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		DUNIS SAUCEDO - Parentesco (madre) - Teléfono (300 3849895)					

Apertura psicología del 2026-01-22 19:36:39: 14 años, 7 meses, y 3 días

DATOS GENERALES

Remisión

PARTICULAR

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre, “Yo quiero que ella sea consciente de sus emociones y exprese y hable de una manera adecuada lo que ella siente” “es una niña callada, se encierra en sí y no da respuestas” “en el colegio cuando está presentando examen y los docentes le piden el examen no lo entrega, no habla y no lo entrega sino hasta que ella quiere” “ella coge rabia y contesta mal cuando se le insiste”.

Refiere la paciente, “Le tengo confianza a mi mamá a mi papá no” “a veces cuando voy con mi papá a comprar ropa me dice que me apure y yo sobre pienso mucho las cosas” “la actitud de mi papá no me gusta” “mi hermano también es así, yo le hablo normal y de repente me insulta” “me la llevo bien con mi mamá, tiene mucha más paciencia, me da concejos y ella entiende lo que yo le estoy expresando” “extraño vivir con mis papás” “quiero adecuar el cuarto como para mí y no puedo porque es el cuarto de mi abuela” "no me gusta participar en clases donde tenga que hablar a mis compañeros me da pena, siento que se van a reir de mi".

Enfermedad Actual

Paciente que acude a consulta por sintomatología caracterizada por alteraciones en la conducta y el estado de ánimo. Se describe tendencia al aislamiento social, permaneciendo gran parte del tiempo en su habitación, con restricción en la expresión emocional y bajo nivel de comunicación verbal.

El cuadro presenta una evolución aproximada de cuatro (4) años, con agudización de los síntomas desde hace tres (3) años, manifestándose episodios de irritabilidad ocasional y fluctuaciones del estado de ánimo.

Según refiere la madre, la paciente muestra afecto plano o restringido en la mayoría de situaciones sociales y familiares. Durante estos contextos se presenta callada, con dificultades para mantener conversaciones de manera fluida, evidenciando bloqueos en momentos que requieren participación activa, como intervenciones en clase. Asimismo, se observa resistencia a tomar iniciativa en interacciones sociales, reportándose mayor tranquilidad y regulación emocional únicamente cuando se encuentra con personas de su círculo de confianza.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

No Refiere

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

No Refiere

Patología

K295 Gastritis Crónica Hace 4 Meses, R196 Halitosis.

Tóxicos

No Refiere

Medicación

Omeprazol, Gabiscon.

Hospitalizaciones

Bronquiolitis A Los Seis (6) Meses De Edad Y Antecedente De Infección Ocular En La Primera Infancia.

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 26 Años	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo 2do	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si	Estado De La Madre Durante El Embarazo Estado Emocional Estable Y Regulado Durante El Periodo De Gestación.

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Programada Por Antecedente De Cesárea Previa.
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3600
Talla Al Nacer 58 Cm	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 6M	Gateo 8M
Bípodo Sin Ayuda 9M	Marcha 12M
Lenguaje Verbal 12M	Lenguaje Verbal Fluido 3 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión Hermano/a	Ansiedad Hermano/a
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Tiroides	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente cursa octavo grado en el Colegio Gimnasio del Norte, ubicado en la ciudad de Valledupar. Refiere mayor afinidad por las asignaturas de arte y física, mientras que manifiesta menor interés por matemáticas y lenguaje. No presenta antecedentes de repitencia escolar. En el ámbito social escolar, se describe como selectiva en la elección de su grupo de compañeros, manteniendo interacción principalmente con un círculo reducido de pares. Sostiene conversaciones de manera funcional con dicho grupo cercano y, en el contexto académico, se expresa de forma concreta y específica cuando los docentes le solicitan participación verbal.
Historia laboral No refiere.
Historia familiar La paciente reside actualmente en la ciudad de Valledupar desde hace aproximadamente dos (2) años, conviviendo con su abuela paterna, la señora Rosa Pua, de 75 años, y su hermano, Santiago Andrés Meriño de 15 años. Los padres la madre Dunis Saucedo de 41 años, y el padre Leonidas Meriño de 46 años, quienes residen en el municipio de Bosconia sin embargo, la comunicación y protección es diaria y eventualmente presencial. La paciente convivió con sus padres en dicho municipio hasta los 10 años de edad. En relación con el entorno familiar con

la abuela y el hermano, se describe una comunicación limitada; sin embargo, la paciente logra expresar sus necesidades y solicitudes básicas. Actualmente mantiene una buena relación con la madre y se encuentra en proceso de fortalecimiento de la comunicación asertiva con el padre y el hermano. De manera general, se reporta una relación familiar funcional, con vínculos estables y disposición al acompañamiento emocional.

Historia social
En el contexto social es selectiva con las amistades y se le facilita integrarse cuando esta en un entorno seguro, realiza aportes a conversaciones y expresar sus ideas cuando se le permite sin juicios o etiquetas.

Historia socio-afectiva
Durante su desarrollo en el ciclo vital, la paciente ha presentado cambios emocionales y conductuales, asociados tanto a los cambios hormonales propios de la etapa evolutiva como al cambio de residencia ocurrido en el año 2021. Dichas manifestaciones se han agudizado en los últimos tres (3) años. En el plano socioafectivo se observa una tendencia a la inhibición emocional, con actitud reservada, escasa iniciativa comunicativa y fluidez verbal disminuida, acompañadas de episodios de irritabilidad. Se resalta que estas conductas se presentan con mayor intensidad en el ámbito familiar, mientras que en otros contextos pueden variar en su expresión.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial
Se realizó entrevista semiestructurada, orientada a la exploración de las áreas funcionales de la paciente, con el objetivo de identificar posibles alteraciones y fortalezas en su funcionamiento emocional, conductual y relacional. Durante el proceso se emplearon técnicas de observación directa y diálogo socrático, lo que permitió profundizar en la comprensión de su experiencia subjetiva y sus patrones de respuesta.
Así mismo, se aplicó la prueba proyectiva Test de la Familia, con el propósito de explorar la percepción subjetiva de la paciente respecto a su núcleo familiar, los vínculos afectivos y la vivencia emocional asociada a dichas relaciones. Los resultados de esta prueba se interpretan de manera cualitativa y complementaria, integrándose con la entrevista clínica y otras fuentes de información, sin valor diagnóstico por sí sola.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica
NO REFIERE

Intervención neurológica
NO REFIERE

Intervención neuropsicológica
NO REFIERE

Otras intervenciones
NO REFIERE

EXAMEN MENTAL

Examen Mental
Paciente Lina María Meriño Saucedo, menor de edad con 13 años, ingresa a consulta acompañada de la madre, la señora Dunis Saucedo. Se observa adecuada presentación personal, acorde a su edad y contexto. Se encuentra orientada autopsíquica y alopsíquicamente. Durante la entrevista, el discurso es coherente y pertinente, aunque de baja espontaneidad verbal. El desarrollo ponderoestatural se observa adecuado para la edad. A nivel conductual, se evidencia actitud reservada, con escaso contacto visual, predominando una expresión facial de enojo sostenida a lo largo de la entrevista.
El estado de conciencia se encuentra lúcido, alerta y vigil. La salud somática impresiona conservada. Se observa actitud poco colaboradora en presencia de la madre, con mayor disposición a la interacción en el espacio privado. A nivel afectivo, se evidencia labilidad emocional, con predominio de afecto irritable y contenido, congruente con el discurso. No se evidencian alteraciones perceptivas; la paciente niega la presencia de alucinaciones, refiere no tener ideas suicidas ni autolesivas al momento de la evaluación. Se observa conciencia parcial de los episodios referidos por la madre, mostrando mayor receptividad y participación durante las actividades y preguntas realizadas en el contexto de la entrevista psicológica individual.

Ciclos del Sueño
CONSERVADOS

Apetito
CONSERVADOS

Actividades de Autocuidado
INDEPENDIENTE, NO REFIERE DEPORTE NI ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):
NREF - NO REFIERE
Impresión Diagnóstica Relacionada 1
NREF - NO REFIERE
Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez
Si

Objeto de atención clínica
Se identifican rasgos de inhibición social y conductas evitativas, asociados a vulnerabilidad emocional, labilidad afectiva y dificultades en la regulación emocional, los cuales interfieren en la comunicación, la iniciativa social y la participación en contextos relacionales significativos.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención
Objetivo General Favorecer la regulación emocional, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo progresivo de habilidades sociales, reduciendo la ansiedad y promoviendo una participación funcional de la paciente en los contextos familiar, escolar y social.
Objetivos Específicos • Identificar y psicoeducar a la paciente y a la familia sobre los síntomas presentados relacionados a la inhibición social y conductas evitativas y sus manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales. • Fortalecer la conciencia emocional, facilitando el reconocimiento, validación y expresión adecuada de emociones. • Desarrollar habilidades sociales básicas y avanzadas, incluyendo comunicación asertiva, contacto visual y manejo de situaciones sociales. • Mejorar la regulación emocional, disminuyendo la irritabilidad, la labilidad afectiva y la inhibición conductual. • Fortalecer los vínculos familiares, promoviendo comunicación asertiva y apoyo emocional consistente.
Sugerencias e Interconsultas NO REFIERE
Observaciones y Recomendaciones • Iniciar tratamiento de Psicoterapia individual, semanal. • Incluir en un deporte de su preferencia. • Acompañamiento del núcleo familiar como red de apoyo mas cercana. • Desarrollar habilidades sociales básicas y avanzadas, incluyendo comunicación asertiva, contacto visual y manejo de situaciones sociales. • Fortalecer los vínculos familiares, promoviendo comunicación asertiva y apoyo emocional consistente. • Promover actividades extracurriculares acordes a sus intereses, con baja demanda inicial.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER